

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	肺癌 Lung Cancer				
編號	A31000-Q03-W-K06	制定者	N14 李美樺	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 4.1 版/13 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解肺癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

指生長於支氣管或肺泡的惡性腫瘤，一般是以由支氣管上皮細胞所形成的支氣管原發性肺癌為主，加上少數的肺泡細胞癌。依組織切片分類為兩類型，即小細胞癌(small cell lung cancer；SCLC)和非小細胞癌(non-small cell lung cancer；NSCLC)；非小細胞癌又可細分成：鱗狀上皮癌、腺癌、大細胞型肺癌及其他四種。

（二）分期

第一期：治療以根治為目標，主要為手術切除，必要時術後輔助治療。

IA：腫瘤≤3 公分，局限於肺，無淋巴結轉移（T1a-c N0 M0）。

IB：腫瘤>3 公分但≤4 公分，無區域淋巴轉移（T2a N0 M0）。

第二期：治療以根治為目標，主要為手術切除，必要時術後輔助治療。

IIA：腫瘤>4 公分≤5 公分，無區域淋巴結轉移（T2b N0 M0）。

IIB：腫瘤>5 公分≤7 公分，無淋巴結轉移（T3 N0 M0）；或腫瘤≤5 公分，區域淋巴結陽性（T1-T2 N1 M0）；或腫瘤侵犯胸壁、橫膈膜、心包等（T3

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	2/13

N0-1 M0)

第三期：

III A：腫瘤任一大小，區域淋巴結同側縱膈、肺門或隆突轉移（T1-T2 N2 M0）；或腫瘤>7 公分或侵犯鄰近結構但 N0-1。

III B：腫瘤侵犯鄰近結構或區域淋巴結對側轉移（T3-T4 N2-N3 M0）

III C：腫瘤 T4，對側縱膈/肺門/鎖骨上淋巴結轉移（T4 N3 M0）

第四期：治療目標以系統性治療（標靶藥物、免疫治療或化療）為主，延長存活及控制症狀。

IV A：單一器官遠處轉移或胸腔/心包惡性積液（M1a/M1b）。

IV B：多器官遠處轉移（M1c）。

（三）症狀

肺癌的臨床表徵可呈多樣化。從毫無自覺之症狀，到長期性乾咳及聲音沙啞，到胸部疼痛、咳血及呼吸困難、不明發燒、體重減輕、食慾不振等症狀。

（四）常見檢查

1. 胸部 X 光檢查(Chest X-ray)。
2. 支氣管鏡檢查(Bronchoscopy)。
3. 低劑量電腦斷層(Low dose computed tomography；LDCT)。
4. 腹部超音波掃描(Abdomen echo)。
5. 全身骨骼核子醫學掃描(Bone scan)。
6. 正子放射斷層攝影(Positron Emission Tomography；PET)。
7. 痰液細胞學檢查(Sputum cytology)。
8. 支氣管鏡細胞學或組織學檢查(Bronchoscope cytology or pathology)。
9. 經超音波或電腦斷層之指引下進行經皮表穿刺的細針抽吸細胞學檢查(Echo-guide or CT-guide transthoracic needle aspiration cytology)。
10. 核磁共振(Magnetic resonance imaging)。

（五）常見治療

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	3/13

1. 小細胞癌(SCLC)

- (1)以化學治療為主，常用 cisplatin 合併 etoposide(VP-16)（簡稱 EP）；或 cyclophosphamide，adriamycin(doxorubicin)，以及 Vincristine(三者簡稱 CAV)。
- (2)若為侷限性癌病期，則可考慮合併使用放射線治療，提高局部控制率。

2. 非小細胞癌(NSCLC)

- (1)手術切除：對於早期 NSCLC 首選治療。。
- (2)放射線治療：對於手術不可切除或作為術後輔助。
- (3)化學治療：主要作為術後輔助或晚期治療，常用藥物包括：
 - A. 紫杉醇類（Paclitaxel、Docetaxel）
 - B. 长春花鹼類 Vinorelbin。
 - C. 抗代謝藥物如 Gemcitabine。
 - D. 常與 Cisplatin、Epirubicin、Carboplatin 等合併使用。
- (4)經支氣管鏡行雷射治療。
- (5)標靶藥物及免疫治療：根據 EGFR、ALK、ROS1 或 PD-L1 表達給予個人化治療。

3. 輔助治療

- (1) Port-A 植入手術。
- (2) 胸腔放液術。
- (3) pig-tail 引流術。

（六）護理問題

1. 易感染／化學治療（放射線治療）、手術、侵入性醫療程序。
2. 缺乏營養／放射線治療（化學治療）、手術、疾病。
3. 組織狀態不完整／放射線治療。
4. 無法有效呼吸／與氣流減少有關、與肺擴張減少有關（如：肋膜積水）。
5. 長期疼痛／與慢性疾病有關（癌症）。
6. 焦慮感受／與疾病有關、與手術有關。

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	4/13

(七) 護理措施

1. 易感染／化學治療（放射線治療）、手術、侵入性醫療程序

- (1) 接觸病人前後洗手。
- (2) 依醫囑測量生命徵象。
- (3) 監測可顯示感染的實驗室檢查（如：CBC），並報告異常現象。
- (4) 監測輸液注射部位有無感染情形。
- (5) 監測傷口滲出液之顏色、氣味、濃稠度及癒合情況。
- (6) 監測引流液之顏色、性質及量。
- (7) 指導病人或主要照顧者，炎症反應症狀（如：紅、腫、熱、痛）及徵象（如：發燒、流膿）。
- (8) 指導病人或主要照顧者，引流管勿高於穿刺部位，維持引流管通暢性及密閉性。
- (9) 視需要限制訪客或安置於隔離病房、個人房，保持環境乾淨，空氣品質良好，必要時做環境消毒。
- (10) 避免壓迫傷口並協助、教導翻身方式。
- (11) 指導病人或主要照顧者，預防感染的方法（如：接觸病人前洗手、限制訪客、保持傷口清潔及乾燥，避免壓迫傷口、正確用藥、注意衛生、營養充足等），並評估其瞭解的程度。
- (12) 以無菌技術執行侵入性治療。
- (13) 視需要更換敷料，保持傷口清潔及乾燥。
- (14) 依醫囑按時給予藥物。
- (15) 若病人情況許可，與醫師討論儘早拔除侵入性治療的管路，以預防感染的發生。
- (16) 評估病人營養狀況，教導選擇高熱量、高蛋白、高維生素飲食。

2. 缺乏營養／放射線治療（化學治療）、手術、疾病

- (1) 依醫囑測量體重。

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	5/13

- (2) 計算病人每日所需攝取熱量及實際食物攝取熱量。
- (3) 依醫囑監測血清白蛋白檢驗值變化。
- (4) 教導進食前給予口腔護理以增加味覺。
- (5) 少量多餐，一天約 4-6 餐，減少腹部鼓脹感和消化的負擔，以增加進食量。
- (6) 避免短時間大量進食以減少代謝的負擔。
- (7) 配合病人食物喜好選擇高蛋白質、高熱量食物。
- (8) 建議清淡飲食，避免辛辣、刺激性食物，及避免選擇會增加唾液黏稠度（如：全脂奶、巧克力、蘇打）、需用力咀嚼（如：豆類、洋蔥、黃瓜、玉米）的食物、含咖啡因或酒精性的飲料（因會利尿可能導致脫水）。
- (9) 注意藥物所帶來的副作用，如噁心、嘔吐；可提供冷食有助於改善噁心、嘔吐情形。
- (10) 記錄每日輸出入量。
- (11) 鼓勵與家人、親友一起進食，講些故事、笑話，或談些家務事，可助於增加用餐的愉悅感，而促進食慾，勿將一些藥物的瓶瓶罐罐擺在餐桌上，影響食慾。教導進食時需坐直，下巴稍微向下、向內，以利吞嚥，及避免噎到；小口餵食，可免除滿口都是食物的不適。
- (12) 教導可多漱口（以開水或食鹽水），以減輕口乾程度，尤其在進食前，食物烹調可藉芎芡或加些湯汁來增添食物的濕潤度，或者可以口含碎冰以改善口乾。
- (13) 提供安靜且不受干擾的環境並給予心理支持。

3. 組織狀態不完整／放射線治療

- (1) 觀察並記錄皮膚黏膜完整性、濕度、顏色。
- (2) 教導選擇高蛋白、高維生素飲食（如：維生素 A、B、B1、B5、C、D）、水份的攝取，以促進傷口修復再生。
- (3) 注意觀察照射部位皮膚之變化。

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	6/13

(4) 避免刺激或按摩照射部位皮膚。

(5) 避免使用肥皂清潔照射部位皮膚。

(6) 勿隨意在治療部位擦潤滑劑或乳液。

4. 無法有效呼吸／與氣流減少有關、與肺擴張減少有關（如：肋膜積水）

(1) 監測組織缺氧的徵象（如：心智狀況改變、心跳過速、頭痛、發紺、易怒和異常呼吸音），並報告醫師。

(2) 依醫囑監測生命徵象，並報告異常現象。

(3) 監測脈搏血氧分析值（如：on Pulse Oximeter、EKG Monitor），並報告異常現象。

(4) 協助病人做實驗室檢查（如：動脈血液氣體分析、血液檢查、細胞學），追蹤結果並報告異常現象。

(5) 協助病人做胸部 X-光檢查，並追蹤結果。

(6) 協助病人採最佳臥姿（如：坐臥、半坐臥），以獲得足夠換氣和氧合狀況。

(7) 協助病人執行日常生活活動，以保留體力和減少耗氧量。

(8) 鼓勵病人在活動前、後需要休息，以免組織缺氧情形惡化。

(9) 當病人呼吸次數大於 30 次／分以上，教導暫勿由口進食，以維持呼吸道通暢。

(10) 依醫囑給予氧氣治療，並鼓勵深呼吸。

(11) 教導和示範改善呼吸的方法和換氣的姿勢【如：噤嘴呼吸（呼氣時緩慢且嘴唇如吹口哨的呼吸法）、橫膈膜呼吸及三點姿勢（坐著時身體向前傾，手臂放兩側膝蓋上，肩胛微抬高、交替坐直和左側臥）】，以獲得足夠換氣和氧合狀況。

(12) 依醫囑予藥物治療（如：支氣管擴張劑、祛痰劑、類固醇、抗生素、止痛劑、利尿劑），並評估藥效、副作用及病人反應。

(13) 病人呼吸急促時，鼓勵家屬陪伴，給予心理上的支持。

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	7/13

5. 長期疼痛/與慢性疾病有關（癌症）

- (1) 評估病人的疼痛部位、程度（0 分不痛～10 分最痛）、頻率（間歇、持續）、發作時間、持續時間及特徵（鈍痛或灼熱痛、深沈或表淺痛），並記錄疼痛的變化。
- (2) 監測病人生命徵象的變化，例如：疼痛時，心跳增加、呼吸淺快。
- (3) 與病人或家屬確認引發疼痛的因素，例如：個人的、與疾病有關的。
- (4) 與病人討論以前所使用及目前在使用有效的止痛方法。
- (5) 與病人或家屬討論減少或排除疼痛的方法。
- (6) 轉移病人注意力，例如：聽音樂、看電視、散步、閱書、聊天。
- (7) 在病人選擇疼痛控制方法時，給予支持與指導。
- (8) 鼓勵家屬多陪伴，增加安全感。
- (9) 提供少刺激的環境，維持病房的安寧。
- (10) 依醫囑予疼痛部位使用藥物（例如：骨骼肌鬆弛劑、鎮靜劑、止痛劑）。
- (11) 評估疼痛控制技巧的效果。
- (12) 評估藥物的效果及副作用。

6. 焦慮感受／與疾病有關、與手術有關

- (1) 評估病人焦慮程度及主要原因。
- (2) 與病人建立信任關係，引導病人說出焦慮原因。
- (3) 對病人說話速度平靜緩慢，耐心傾聽病人主訴，尋找引起焦慮的原因。
- (4) 安排舒適環境並給予詳細的環境介紹，鼓勵病人討論其感覺和害怕。
- (5) 增加病人安全感，在做治療前給予詳細解釋。
- (6) 注意評估病人焦慮改善狀態。
- (7) 請醫師解釋疾病發展過程協助病人確認可能的壓力來源。
- (8) 安排病人喜歡的環境，分散注意力，減輕焦慮，如：聽音樂、聊天。
- (9) 安排病人熟悉物品，如：玩具、照片、棉被、飾品等等，以減輕焦慮。
- (10) 經常探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	8/13

(八) 衛教指導

1. 疼痛衛教

- (1) 衛教病人確實告訴醫護人員藥物治療後的反應，醫師才能適當的給藥，協助其擁有良好的生活品質。
- (2) 衛教病人適時反應疼痛，醫護人員並不會感到厭煩，反而能藉此給予適當的幫助。
- (3) 教導病人忍耐疼痛不是一種勇敢的表現，應該拒絕疼痛干擾其生活。
- (4) 好的疼痛控制會幫助病人順利地接受治療，使其更有勇氣面對疾病的挑戰。

2. 化學藥物治療病人之照護

- (1) 化學治療藥物對人體各器官或組織細胞均造成毒性作用，依據各種不同的化學藥物及劑量，所產生的毒性作用也不同。一般常見化學治療的副作用有：噁心、嘔吐、口腔黏膜炎、骨髓抑制、掉髮、注射部位靜脈炎、腹瀉等。大多數的副作用症狀均可被有效的控制，因此需事先依醫囑按時給予預防性藥物。
- (2) 衛教病人於化學藥物注射期間，如遇任何不適症狀，如：嚴重嘔吐、呼吸急促、心悸或其他身體不適症狀，需立即告知醫護人員，經由醫護人員評估後，決定是否暫停或減低治療速度。
- (3) 衛教病人化學藥物治療期間，勿任意自行調整藥物滴注速度，以免影響治療效果或增加毒性作用程度。
- (4) 化療藥物如滲出血管外造成皮膚下發紅、腫脹、發熱、疼痛等現象時，應立即告知醫護人員，不要忍耐或隨意自行塗抹任何藥物及冷熱敷（藥物及冷熱敷需由醫護人員評估施打藥物及藥物外滲量後，在醫護人員的指導下執行）。
- (5) 化學藥物如不慎濺漏到皮膚上或身體其他部位時，請立即告知醫護人員處理，同時並以大量清水沖洗藥物外漏部位。

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	9/13

- (6) 化學藥物施打期間，請勿憋尿。如無噁心嘔吐現象時，可飲用適量的水分加速藥物排出體內，減輕藥物對腎臟及膀胱的傷害。如下床不便者，可於治療前排空膀胱或穿上尿褲。
- (7) 化學藥物治療會造成食慾降低，此時無需強迫進食，但可在治療前準備一些小點心在床旁，以便隨時取用。
- (8) 如無噁心、嘔吐或嚴重口腔炎時，化學藥物治療期間，不需刻意挑食。
- (9) 化學藥物治療期間，在不影響藥物滴注的情況下，仍可下床活動。
- (10) 鼓勵病人下床進行輕度活動，以分散治療副作用的不適現象。化學治療結束後返家期間，依據各種不同注射藥物，發生骨髓抑制時間不同，一般來說大約在 7-14 天左右。此時病人應減少進出人多的地方，以免造成感染。

(九) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 王桂芸、李惠玲(2020)。呼吸系統疾病之護理。於劉雪娥總校閱。台北：華杏，1144-1155。
- (二) 謝煊亘、江起陸、邱昭華 (2021)。小細胞肺癌的診斷與治療。臨床醫學月刊，87(6)，373-380。[https://doi.org/10.6666/ClinMed.202106_87\(6\).0062](https://doi.org/10.6666/ClinMed.202106_87(6).0062)
- (三) 沈佳儀、邱昭華 (2021)。低劑量電腦斷層在肺癌篩檢的角色與運用。臨床醫學

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	10/13

月刊，87(5)，277-282。 [https://doi.org/10.6666/ClinMed.202105_87\(5\).0045](https://doi.org/10.6666/ClinMed.202105_87(5).0045)

- (四) 沈季香、楊麗玉、楊志仁 (2023)。台灣南部肺癌病人存活時間的預測因子。台灣醫學，27(4)，399-407。 [https://doi.org/10.6320/FJM.202307_27\(4\).0001](https://doi.org/10.6320/FJM.202307_27(4).0001)

七、附件

(略)

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	11/13

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
100.08.31	2.1	修改說明內容。	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
101.08.31	2.2	醫護部修改成護理部。	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
102.08.31	3.1	說明內容部份修辭。	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	說明內容修辭潤飾及標點符號修正。	103 年 08 月 31 日通過護理部照護標準委員會。
104.08.31	3.3	第六項參考資料文獻部份內容更新。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.4	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 更新第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.5	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第六目之 1(2)之 2(1)新增依醫囑並刪除每____小時。 3. 第三項第六目之 1(14)；之 4(2)(4)(10)部份文字刪除。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	12/13

修正日期	版本	修正說明	備註
108.09.23	3.6	1. 第三項第三目之 3 新增 3.低劑量電腦斷層 (Low dose computed tomography,LDCT)。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第六項新增參考資料。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.7	1. 新增第三項第二目分期說明。 2. 第六項新增參考資料。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過; 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.09.07	3.8	第六項新增參考資料。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過; 110 年 08 月 11 日護理長會議通過;110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	3.9	1. 第三項第四目說明內容文字修訂。 2. 更新第三項第六、七目護理問題。 3. 更新第六項參考文獻資料。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過; 111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.10.26	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	4.0	更新第六項參考文獻資料。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過; 113 年 12 月 11 日護理長會議通過;113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	4.1	1.第三項第二目-分類依照 TNM 語言標準化。 2.第三項第五目治療說明內容文字修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過; 114 年 12 月 10 日護理長會議通過;115 年 01 月 06 日督導會議

主題名稱	肺癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K06	版本	第 4.1 版	頁碼/總頁數	13/13

修正日期	版本	修正說明	備註
			通過公布。